



Un ensayo en The Lancet Psychiatry halla mejor funcionamiento psicosocial con psicoterapia psicodinámica modificada en esquizofrenia, otro en JAMA Network Open asocia una intervención perioperatoria a menos depresión y ansiedad en mayores y la ANECA presenta un marco de autoevaluación universitaria: claves del 3 de octubre de 2026

SÁBADO 3 DE OCTUBRE DE 2026

Resumen rápido del día

Un ensayo aleatorizado publicado en The Lancet Psychiatry con 130 pacientes ambulatorios halla que añadir psicoterapia psicodinámica modificada al tratamiento habitual se asocia con un mejor funcionamiento psicosocial en esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo, con limitaciones por las pérdidas de seguimiento. Otro ensayo, publicado en JAMA Network Open con 306 personas de 60 años o más que iban a ser operadas, observa menos síntomas depresivos y ansiosos a los 3 meses con una intervención psicológica y farmacológica, con efectos distintos según el tipo de cirugía. Infocop recoge además un artículo sobre ciberbullying con datos de la Fundación ANAR y el marco de autoevaluación MAIC de la ANECA, que propone a las universidades impulsar una ciudadanía activa, crítica y responsable.

HERRAMIENTA · NACIONAL

La ANECA presenta un marco de autoevaluación para que las universidades impulsen una ciudadanía activa, crítica y responsable

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha publicado el Marco para la autoevaluación de las universidades en la mejora de sus actuaciones encaminadas al impulso de una ciudadanía activa, crítica y responsable, conocido como MAIC, según informa Infocop el 30 de septiembre de 2026. Se trata de un extenso documento que ofrece a las instituciones universitarias un marco operativo para revisar y mejorar sus actuaciones en este campo. Constituye la tercera iniciativa de esta línea del Observatorio de la Calidad del Sistema Español de Universidades, tras los trabajos dedicados a la empleabilidad y a la inclusión. El marco se articula en cinco objetivos específicos, que se concretan en 27 líneas de actuación con sublíneas y ejemplos de posibles acciones. Propone incorporar en todas las enseñanzas competencias en ciudadanía democrática, derechos humanos y desarrollo sostenible, adaptadas a cada disciplina, junto con metodologías que conecten el aprendizaje con la realidad social, como el aprendizaje-servicio o el aprendizaje basado en proyectos. Para elaborarlo, la ANECA consultó a organismos como la UNESCO, el Consejo de Europa y la European Students' Union (ESU). En total participaron 53 universidades, 19 de ellas en el grupo de trabajo que consolidó el marco, y una encuesta realizada entre junio y septiembre de 2025 recogió las valoraciones de 52 universidades. El documento incluye una guía de autoevaluación para que cada universidad identifique fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora, y mantiene el respeto a la autonomía de cada institución. El informe recuerda, además, que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ya incluye entre las funciones del sistema universitario la formación de la ciudadanía.

Fuente: Infocop, a partir del documento de la ANECA

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

Infocop repasa las claves para comprender, prevenir y abordar el ciberbullying, con datos de la Fundación ANAR sobre el uso de la inteligencia artificial

Infocop publica un extenso artículo que reúne la evidencia disponible sobre el ciberbullying, definido como una agresión intencional ejercida mediante tecnologías digitales, habitualmente en el contexto de las relaciones entre iguales. El texto subraya que, al desaparecer buena parte de las fronteras espacio-temporales, el daño puede continuar fuera del centro escolar y que un solo contenido humillante puede compartirse innumerables veces. Entre los datos que recoge figura que, en Europa, aproximadamente uno de cada seis adolescentes de entre 11 y 15 años ha sufrido ciberbullying y cerca de uno de cada ocho reconoce haberlo ejercido. Para España cita el último informe de la Fundación ANAR: el 14,1% del alumnado afirma que él o algún compañero o compañera de clase sufre acoso escolar y/o ciberbullying, con WhatsApp (78,4%), TikTok (65,6%) e Instagram (50,4%) como medios más señalados en los casos de ciberbullying. La inteligencia artificial aparece en el 23,5% de los casos conocidos, sobre todo para crear vídeos falsos a partir de fotografías (79,5%). En cuanto al abordaje, el artículo describe el apoyo parental como uno de los factores protectores más consistentes, advierte de que retirar el móvil de forma automática puede ser contraproducente si el o la menor lo interpreta como perder su principal vía de relación social, y recomienda intervenir también con quien agrede, con un enfoque de reeducación, responsabilidad y reparación del daño. Sostiene asimismo que los centros necesitan profesionales capacitados para ofrecer una respuesta integral, entre ellos los de la Psicología Educativa.

Fuente: Infocop (Redacción de Infocop)

Noticias internacionales

CLÍNICA · INTERNACIONAL

Una intervención psicológica y farmacológica perioperatoria reduce la depresión y la ansiedad en mayores operados, con efectos que varían según el tipo de cirugía

JAMA Network Open publica un ensayo clínico aleatorizado, con autoría vinculada a la Universidad Washington en San Luis (WashU Medicine), que evalúa una intervención perioperatoria para optimizar la salud mental de personas de 60 años o más con síntomas de depresión o ansiedad clínicamente relevantes antes de una cirugía cardíaca, oncológica u ortopédica. Se analizaron 306 participantes (edad media de 68,5 años; 68,3% mujeres), repartidos en tres ensayos vinculados: 102 de cirugía cardíaca, 100 de oncológica y 104 de ortopédica. La intervención combinaba manejo psicológico, basado en activación conductual y apoyo, a cargo de trabajadores sociales o consejeros con máster y por teléfono, con optimización farmacológica dirigida por farmacéuticos con supervisión de un psiquiatra geriátrico, que incluía la deprescripción de fármacos del sistema nervioso central potencialmente inapropiados. El grupo control recibió atención habitual mejorada, con materiales escritos de autogestión. A los 3 meses de la operación, la puntuación en la escala PHQ-ADS descendió significativamente más en el grupo de intervención (diferencia media de 2,20; IC 95% 0,16-4,24). El efecto varió por subgrupo: 4,93 en cirugía oncológica, 2,68 en cardíaca y -1,11 en ortopédica, sin significación estadística en estas dos últimas. No hubo diferencias en delirium, estancia hospitalaria, reingresos ni caídas. Los autores señalan limitaciones, como un único sistema sanitario y la exclusión de personas con deterioro cognitivo grave, y piden estudios mayores que confirmen los resultados.

Fuente: JAMA Network Open (Abraham et al., 2026), a través de PubMed Central

Publicaciones científicas recientes

Montag, C., Bröcker, A.-L., Bayer, S., Becker, K., Bertram, G., Büttner, M., Funcke, J., Grimm, I., Just, S.-A., Hadzibegovic, J., Maaßen, E., Nenchev, I., Stuke, F., BERPohl, F., Heinz, A., Lempa, G., & von Haebler, D. (2026). The efficacy of modified psychodynamic psychotherapy for patients with schizophrenia-spectrum disorders in Germany: A prospective, single-centre, assessor-blinded, parallel-group, randomised controlled trial. *The Lancet Psychiatry*, 13(10), 870-883.

[https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(26\)00240-3](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(26)00240-3)

DOI: [10.1016/S2215-0366\(26\)00240-3](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(26)00240-3)

Hallazgo: Entre octubre de 2015 y diciembre de 2021 se asignó al azar a 130 pacientes ambulatorios con esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo a MPP-S

más tratamiento habitual (65) o a tratamiento habitual solo; el resultado principal se analizó en 129 personas. Con la escala Mini-ICF-APP, la diferencia ajustada entre grupos fue de -3,45 puntos (IC 95% -5,51 a -1,40; $p = 0,0011$) a los 24 meses y de -4,07 (-6,19 a -1,94; $p = 0,0002$) a los 36 meses, con tamaños del efecto entre grupos (g de Hedges) de 0,70 y 0,93. La escala SANS de síntomas negativos también mostró diferencias a favor de la intervención (g de 0,83 y 1,07), mientras que en los análisis primarios no hubo interacciones significativas para síntomas positivos medidos con la SAPS, para los síntomas positivos de la PANSS ni para la sintomatología depresiva. La frecuencia de efectos adversos fue similar entre grupos y se registraron tres eventos adversos graves: dos fallecimientos por suicidio, uno en cada grupo, y un ingreso en un hospital forense. Las pérdidas de seguimiento fueron notables: el 29% de las visitas previstas tras el tratamiento y el 48% de las del seguimiento no se realizaron.

Implicación clínica: Los resultados sugieren que una psicoterapia psicodinámica adaptada y manualizada podría ser un complemento del tratamiento habitual en los trastornos del espectro esquizofrénico, en especial para el funcionamiento psicosocial y los síntomas negativos. Los autores piden, antes de extraer conclusiones firmes, replicar el estudio con muestras mayores e independientes y compararlo con condiciones de control activas, como la terapia cognitivo-conductual para la psicosis.

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Escala Mini-ICF-APP para valorar el funcionamiento psicosocial:** El ensayo de The Lancet Psychiatry midió su resultado principal con la Mini-ICF-APP, una escala evaluada por clínicos que valora limitaciones de actividad y participación en trastornos psicológicos y se inspira en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud de la OMS. Cuenta con 13 ítems puntuados de 0 (sin deterioro) a 4 (incapacidad total), se aplica mediante una entrevista de unos 30 minutos y las puntuaciones más altas indican menor funcionamiento. Según los autores, no se basa en la psicopatología, sino que compara el estado actual con el previo a la enfermedad, y en el estudio mostró una buena consistencia interna (alfa de Cronbach de 0,87 al inicio).

– **Cuestionario PHQ-ADS para cuantificar síntomas de depresión y ansiedad:** El ensayo de JAMA Network Open empleó el PHQ-4 como cribado inicial y la PHQ-ADS, de 16 ítems, que combina el PHQ-9 y el GAD-7, tanto para seleccionar a los participantes (puntuación igual o superior a 10) como para medir el cambio a los 3 meses. Su rango va de 0 a 48 y las puntuaciones más altas indican mayor carga de síntomas. Los autores indican que la diferencia mínima importante dentro de una misma persona ronda los 4 puntos, mientras que no existe consenso sobre el umbral clínicamente relevante para las diferencias entre grupos.

Prioridades del día

Explorar la vida digital en el trabajo con infancia y adolescencia

Puede ser útil incorporar preguntas sobre el uso de redes, mensajería y herramientas de inteligencia artificial cuando se trabaja con niños, niñas y adolescentes, dado que el artículo de Infocop recoge que la agresión digital puede continuar fuera del centro escolar y que los códigos comunicativos de los menores evolucionan con rapidez. También puede ser relevante tener presente que, según el texto, retirar el móvil de forma automática puede resultar contraproducente si el o la menor lo vive como perder su principal vía de relación social.

Valorar los síntomas emocionales de las personas mayores antes de una cirugía

Puede ser relevante tener en cuenta que, en el ensayo de JAMA Network Open, las personas de 60 años o más con síntomas de depresión o ansiedad mostraron una mayor reducción de síntomas a los 3 meses con una intervención psicológica y farmacológica, aunque el efecto varió según el tipo de cirugía y los autores piden confirmación en estudios más amplios. Puede ser oportuno explorar, en coordinación con quienes prescriben, qué medicación activa sobre el sistema nervioso central toma cada paciente de este grupo de edad.

Seguir la evidencia sobre psicoterapia complementaria en el espectro esquizofrénico

Puede ser oportuno seguir los resultados de la psicoterapia psicodinámica modificada para la esquizofrenia, cuyo ensayo en Berlín aporta datos de funcionamiento psicosocial y síntomas negativos a los 24 y 36 meses, aunque con limitaciones señaladas por los propios autores: un único centro, pérdidas de seguimiento y un control sin psicoterapia manualizada equivalente. Puede ser útil esperar a replicaciones y comparaciones con tratamientos activos antes de extraer conclusiones sobre su lugar en la atención.

